Bài 25 SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH

Trần Bảo Long

zalo nhóm 0528112107

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Hiểu được giải phẫu đường mật ứng dụng trong bệnh sỏi đường mật và nguyên nhân tạo sỏi mật.

2. Trình bày được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của sỏi đường mật và các biến chứng cấp tính.

3. Diễn giải được nguyên tắc và các phương pháp điều trị sỏi đường mật và các biến chứng cấp tính.

4. Vận dụng được kiến thức bệnh lý sỏi đường mật trong giáo dục sức khỏe phòng tái phát sỏi đường mật.

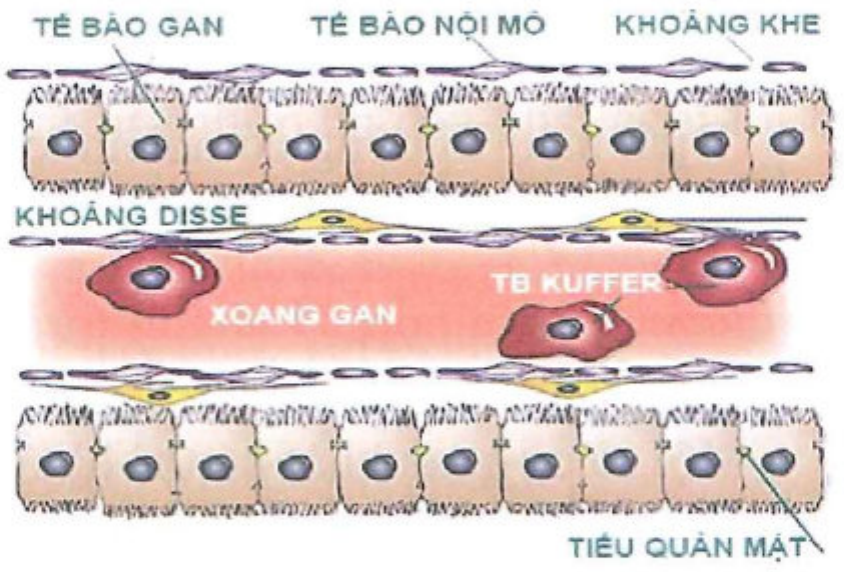
NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Giải phẫu đường mật, sinh lý dịch mật

- Đường mật bắt đầu từ các khe giữa các tế bào gan nhận dịch mật từ tế bào gan tiết ra, ngăn cách với hệ mao mạch gan bởi chỗ dính của màng tế bào gan (cầu tế bào), sau đó dịch mật theo các ống này đổ vào các nhánh hạ phân thùy, phân thùy gan, các ống gan phải và gan trái rồi chảy vào ống gan chung ở rốn gan. Ống gan chung đổi tên là ống mật chủ khi ống cổ túi mật đổ vào. Ống mật chủ dài chừng 5 - 7 cm, đường kính khoảng 0,8 cm chạy tiếp xuống dưới và phần lớn đổ vào đoạn II của tá tràng qua bóng Vater. Đường mật gồm đường mật chính (đường mật trong gan và đường mật ngoài gan bao gồm ống gan chung, ống mật chủ) và đường mật phụ gồm ống cổ túi mật và túi mật.

- Lượng dịch mật được dự trữ, cô đặc ở túi mật tương đương với lượng dịch mật tiết ra trong 12 giờ (khoảng 500 ml), chỉ chảy xuống tham gia tiêu hóa theo sự chi phối của cơ chế thần kinh và thể dịch. Bình thường, dịch mật vô khuẩn nhờ cơ chế bảo vệ của hàng rào giải phẫu, cơ chế vật lý dòng chảy một chiều của dịch mật, cơ chế hóa học (tính chất kiềm của dịch mật) và cơ chế miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào.



Hình 1. Tiểu quản mật

- Áp lực đường mật bình thường $< 20\ cmH_20$. Khi tăng $\geq 25\ cmH_20$ gây nguy cơ phá vỡ cầu tế bào làm nhiễm khuẩn máu và khi $\geq 30\ cmH_20$ sẽ làm tế bào gan ngừng bài tiết dịch mật.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2. Sỏi mật

2.1. Cơ chế tạo sỏi

Sỏi mật ở các nước Âu, Mỹ hay gặp ở túi mật do cơ chế tạo sỏi thường do rối loạn chuyển hóa tạo nên sỏi cholesterol, sỏi đường mật thường là thứ phát.

Trái lại, sỏi mật ở nước ta thường gặp ở đường mật cả trong và ngoài gan, hình thành do cơ chế nhiễm khuẩn có liên quan mật thiết với giun chui ống mật. Tôn Thất Tùng đưa ra kết luận khi giun chui ống mật gây viêm giãn đường mật và hình thành sỏi gan. Nguyễn Thuyên chứng minh bằng mô hình toán học sau khi giun chui ống mật đến khi bắt đầu có triệu chứng sỏi đường mật trung bình là 18 tháng. Kết luận này phù hợp với nghiên cứu của Asakura và Maki ở Nhật Bản: Hơn 55% số sỏi mật có chứa trứng hoặc xác giun. Vi khuẩn từ ống tiêu hóa lên tiết ra enzym β glucoronidase phân hủy dạng liên hợp giữa bilirubin và acid glucuronic làm bilirubin trở thành dạng tự do không hòa tan, sẽ kết hợp với các chất vô cơ như calci ... để tạo thành muối bilirubinat calci lắng đọng tạo sỏi. Sỏi hình thành và tồn tại trên khắp hệ thống đường mật cả trong và ngoài gan.

Trong những năm gần đây, sỏi túi mật đơn thuần được thông báo ngày càng nhiều, tỉ lệ sỏi cholesterol cũng cao hơn, có lẽ do chế độ dinh dưỡng dần thay đổi và chẩn đoán có nhiều tiến bộ hơn.

2.2. Một số đặc điểm sỏi mật và thay đổi trong bệnh sỏi đường mật

- Sỏi đường mật chính ở nước ta thường có nhiều viên với hình thái, kích thước khác nhau, ít khi chỉ có 1 viên. Sỏi có màu vàng hay nâu đen. Thường mềm dễ vỡ, nhưng có khi rất rắn. Sỏi được tạo trên cơ sở dị vật như trứng, xác giun đũa hay mảnh tế bào niêm mạc viêm bong.

- Gan: Gan to ứ mật giai đoạn đầu, có thể có các ổ áp xe gan đường mật, do viêm nhiễm kéo dài, tác động của các sản phẩn chuyển hóa trung gian tế bào như IL 6 ...vv làm tăng cường phản ứng viêm mạn, loạn sản, xơ hóa ...vv dẫn tới hiện tượng một phần hay cả gan bị xơ ứ mật và tỷ lệ ung thư đường mật trong gan ở bệnh nhân bị sỏi trong gan tăng cao (từ 1,5-11%).

- Đường mật: Khi tắc mật cấp, đường mật giãn và sung huyết về sau thành viêm dầy, có thể viêm loét thủng, đặc biệt là túi mật. Có thể bị xơ hóa gây chít hẹp đường mật và lại là nguyên nhân gây ứ đọng dịch mật và tạo sỏi.

- Dịch mật: Thường có nhiễm khuẩn, biểu hiện từ nhẹ (vẩn đục) đến nặng (mủ) hay rất nặng (đen thối khẳn). Cấy dịch mật thường có các vi khuẩn đường ruột như *E.Coli, Klebsiella* ... và hình thái nặng có các vi khuẩn kỵ khí như *Bacteroides, Clostridium* ... phối hợp. Ở những trường hợp đã điều trị nhiều lần có nguy cơ kháng thuốc rất cao.

- Một số cơ quan khác có thể bị tổn thương như viêm tụy cấp tính, suy thận ...vv

II. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

Sỏi ống mật chủ đơn thuần hay phối hợp với sỏi trong gan chiếm khoảng 60-80% các trường hợp, sỏi hình thành và tồn tại trong đường mật có thể không gây ra các triệu chứng lâm sàng, phát hiện bệnh tình cờ nhờ chẩn đoán hình ảnh.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Khi sỏi di chuyển đến chỗ hẹp hay có viêm nhiễm phù nề gây tắc đường mật, người bệnh có biểu hiện của viêm đường mật cấp tính.

1.1. Triệu chứng lâm sàng

1.1.1. Triệu chứng cơ năng

- Tam chứng Charcot: Dấu hiệu điển hình của viêm đường mật do sỏi được Jean Martin Charcot mô tả lần đầu năm 1877 với bộ ba triệu chứng xuất hiện và mất đi theo trình tự.

+ Đau bụng vùng gan, điển hình là cơn đau quặn gan, thường rất dữ dội do sỏi di chuyển cọ sát vào đường mật và do gây tắc làm cho áp lực đường mật tăng cao gây giãn đường mật. Có khi đau vùng thượng vị nên dễ nhầm với cơn đau do loét dạ dày tá tràng.

+ Sốt xuất hiện đồng thời hay sau đau vài giờ. Đặc trưng là các cơn sốt có kèm rét run và vã mồ hôi sau đó nhiệt độ có thể trở lại bình thường hoặc hơi tăng.

+ Vàng da, vàng mắt xuất hiện sau đau và sốt 24 - 48 giờ do tắc mật, có thể rất rõ hay kín đáo tùy mức độ tăc mật.

Các triệu chứng trên thường xuất hiện trong thời gian từ 5 - 7 ngày rồi các triệu chứng mất đi hoặc tiến triển nặng hơn.

- Trong các đợt tắc mật có thể đái ít, nước tiểu sẫm màu.

- Tiền sử có nhiều đợt đau - sốt - vàng da như trên, là dấu hiệu rất có giá trị trong chẩn đoán sỏi đường mật.

1.1.2. Triệu chứng toàn thân

- Trong đợt tắc mật cấp, có biểu hiện của hội chứng nhiễm khuẩn và tắc mật như lưỡi bẩn, hơi thở hôi, sốt cao 38 - 39°C và da, mắt vàng.

- Có thể thấy biểu hiện của các biến chứng như sốc nhiễm khuẩn đường mật, suy thận hay dấu hiệu của rối loạn đông máu (có các đám chảy máu ở củng mạc mắt hay dưới da).

1.1.3. Triệu chứng thực thể

- Gan to thường cả hai thùy, mật độ mềm. Khi gan to ấn đau phải nghĩ tới biến chứng áp xe gan đường mật.

- Túi mật to là dấu hiệu rất có giá trị trong chẩn đoán tắc mật cơ học, chiếm tỉ lệ 55 - 65 % trong tắc mật cấp do sỏi mật. Đặc điểm này khác với bệnh cảnh sỏi châu Âu nên định luật Couvoisier "tắc mật do sỏi, túi mật teo. Tắc mật do u, túi mật to" không phù hợp với bệnh lý sỏi mật ở nước ta và nghiệm pháp Murphy ít giá trị.

1.2. Cận lâm sàng

1.2.1. Xét nghiệm

- Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn: Số lượng bạch cầu tăng > 10G/l, chủ yếu tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Protein phản ứng C tăng (CRP: bình thường < 10 mg/l), procalcitonin tăng (bình thường < 0,05 ng/ml).

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Xét nghiệm đánh giá tắc mật: Bilirubin máu tăng chủ yếu là loại trực tiếp, phosphatase kiềm tăng.

- Xét nghiệm đánh giá các rối loạn khác:

+ Suy thận: Ure máu cao, creatinin máu cao.

+ Rối loạn chức năng đông máu: Tỷ lệ prothombin giảm, kéo dài thời gian đông máu. Ở giai đoạn nặng có thể thấy các dấu hiệu của đông máu rải rác trong lòng mạch.

+ Hội chứng hủy hoại tế bào gan: Các men gan SGOT, SGPT tăng cao do các tế bào gan bị hủy hoại.

+ Viêm tụy cấp do sỏi mật: Amylase tụy tăng (> 3 lần giá trị bình thường tối đa).

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh

- ***Siêu âm gan mật:*** Là thăm khám hình thái thường được lựa chọn đầu tiên trong chẩn đoán sỏi mật vì dễ thực hiện, độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Hình ảnh trực tiếp của sỏi biểu hiện bằng hình đậm âm kèm bóng cản âm hình nón, hình ảnh gián tiếp thấy đường mật phía trên sỏi giãn. Cần khảo sát tình trạng nhu mô gan, đường mật, vị trí sỏi, kích thước sỏi, tình trạng ổ bụng và các tạng liên quan để có thái độ điều trị phù hợp.



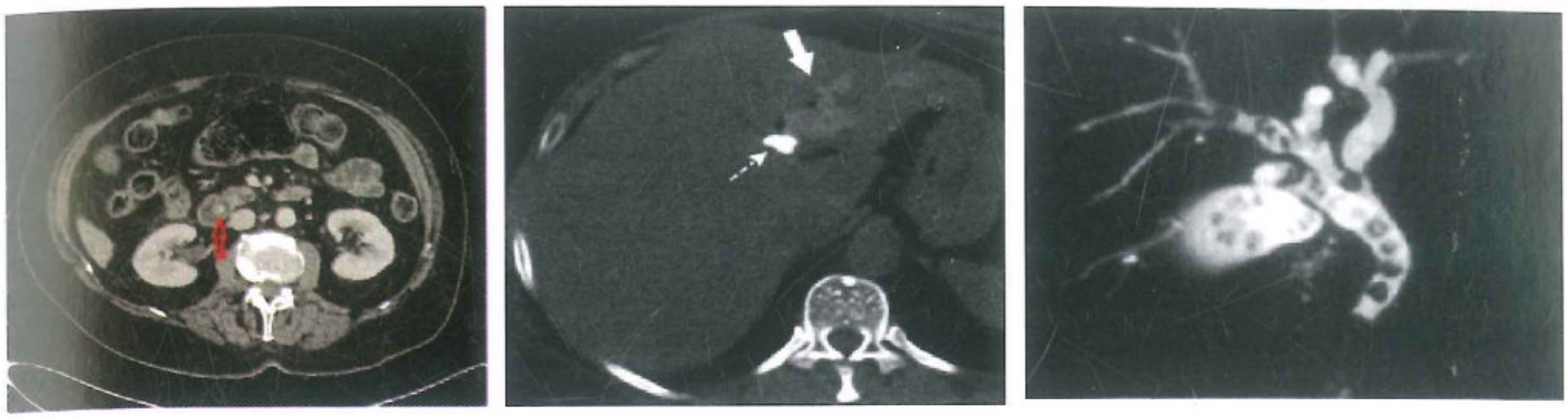
Hình 2. Sỏi mật trên siêu âm

- ***X quang:***

+ Chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) là thăm dò có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý gan mật. Chụp cắt lớp đa dãy có dựng hình còn cho biết thông tin về cây mật (chít hẹp? biến đổi giải phẫu?), vị trí, kích thước sỏi mật, thậm chí cả số lượng sỏi để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, giá thành cao và có nguy cơ sốc phản vệ do tiêm thuốc cản quang nên chỉ áp dụng trong những trường hợp khó phân biệt với bệnh khác. Sỏi đường mật biểu hiện bằng hình ảnh tăng tỷ trọng nằm trong đường mật, giãn đường mật phía trên sỏi. Cần lưu ý, sỏi cholesterol thường đồng tỷ trọng với dịch mật và sỏi nhỏ, sỏi không tăng tỷ trọng có thể bị bỏ sót trên CT Scanner.

- Chụp cộng hưởng từ mật - tụy (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography: MRCP) là thăm dò rất có giá trị trong chẩn đoán tắc mật nói chung và sỏi đường mật nói riêng, được khuyến cáo làm khi siêu âm không rõ ràng, cho biết thông tin về cây mật, sỏi đường mật về vị trí và số lượng sỏi vv.... MRCP có nhiều ưu điểm vượt trội so với chụp cắt lớp vi tính (không xâm lấn, không sử dụng tia rơn ghen, phát hiện được sỏi khi không phát hiện được bằng chụp cắt lớp vi tính, có thể chụp cho người có thai ...vv. Nhược điểm là chi phí cao.

zalo nhóm duy nhất 0528112107



A B C

Hình 3. (A) Sỏi ống mật chủ và (B) Sỏi đường mật gan trái trên phim chụp cắt lớp vi tính; (C) Sỏi ống mật chủ, túi mật và ống gan phải trên phim cộng hưởng từ đường mật

+ Chụp đường mật ngược dòng (ERCP: Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography): Vừa để chẩn đoán vừa để điều trị sỏi ống mật chủ, tỉ lệ biến chứng từ 7-10% (viêm tụy cấp, chảy máu ...).

+ Một số phương pháp khác:

- Chụp đường mật qua da: Được Huart và Đỗ Xuân Hợp thực hiện lần đầu tiên trên thế giới năm 1937. Trong vài thập kỷ gần đây, kỹ thuật này được phát triển mạnh mẽ không những áp dụng trong chẩn đoán nhờ ưu điểm đưa thuốc cản quang trực tiếp vào đường mật nên thấy rõ cây mật, vị trí tắc, bản chất vật tắc, các biến đổi giải phẫu mà kỹ thuật này còn áp dụng trong điều trị bệnh lý đường mật lành tính và ác tính như tán sỏi theo đường xuyên gan qua da, đặt stent đường mật ...vv. Các biến chứng sau chọc có thể gặp như tràn mật ổ bụng, chảy máu trong ổ bụng, chảy máu đường mật, sốc nhiễm khuẩn đường mật.
- Chụp gan xa: Là phương pháp được áp dụng trước đây khi siêu âm chưa phát triển, nhằm tìm bóng gan to, bóng túi mật to, hơi đường mật, phản ứng màng phổi, calci hóa thành túi mật, có khi thấy hình sỏi túi mật cản quang. Ngày nay không sử dụng trong chẩn đoán sỏi mật.

1.3. Chẩn đoán viêm đường mật cấp tính và mức độ nặng

1.3.1. Chẩn đoán viêm đường mật cấp tính

- Theo hướng dẫn Tokyo 2018, chẩn đoán viêm đường mật cấp tính dựa vào các tiêu chuẩn sau:

+ ***A. Biểu hiện toàn thân của viêm***: A1: Sốt, thân nhiệt > 38^0C và/hoặc rét run; A2: Xét nghiệm có phản ứng viêm số lượng bạch cầu < 4 hoặc > 10 G/l, CRP ≥ 1 mg/dl.

+ ***B. Tắc mật:*** B1: Vàng da, bilirubin ≥ 2mg/dL (≥ 34,2µmol/L); B2: Xét nghiệm chức năng gan bất thường - tăng ít nhất 1,5 lần giá trị bình thường: ALP, AST, ALT, gamma glutamyl transferase.

+ ***C. Chẩn đoán hình ảnh:*** C1: Giãn đường mật; C2: Có nguyên nhân trên hình ảnh như chít hẹp, sỏi, stent ...vv.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- *Nghi ngờ khi:* Có 1 tiêu chuẩn A và 1 tiêu chuẩn B hoặc C.
- *Chẩn đoán chắc chắn khi*: Có 1 tiêu chuẩn A, 1 tiêu chuẩn B và 1 tiêu chuẩn C.

1.3.2. Chẩn đoán độ nặng của viêm đường mật

Theo hướng dẫn Tokyo 2018, viêm đường mật cấp tính được chia làm ba mức độ sau:

+ ***Độ 3 (nặng):*** Viêm đường mật cấp tính kèm rối loạn chức năng ít nhất 1 trong các cơ quan sau: Tim mạch (hạ huyết áp phải dùng dopamine $\geq 5\mu g/kg/phút$ hoặc phải dùng norepinephrine). Thần kinh (rối loạn ý thức). Hô hấp ($PaO_2/FiO_2 < 300$). Thận (thiểu niệu, creatinin máu > 2,0 mg/dl). Gan (PT-INR > 1,5). Huyết học (tiểu cầu $< 100.000/mm^3$).

+ ***Độ 2 (trung bình):*** Viêm đường mật cấp tính kèm 2 trong số các tiêu chuẩn sau: Số lượng bạch cầu bất thường (> 12 hoặc < 4 G/l). Sốt cao ($> 39^0C$). Tuổi ≥ 75. Tăng bilirubin (bilirubin toàn phần $\geq$ 5 mg/dl hay > 85,5 µmol/l). Hạ albumin máu (dưới 0,7 lần giá trị bình thường - dưới 24,5 g/l ở người lớn).

+ ***Độ 1 (nhẹ):*** Khi không đạt các tiêu chuẩn độ 2,3.

2. Chẩn đoán phân biệt

2.1. Bệnh nội khoa có vàng da

- Vàng da do tan máu.
- Viêm gan do virus.
- Bệnh do xoắn khuẩn leptospira.

Lâm sàng cần chú ý thứ tự của các dấu hiệu đau, sốt và vàng da có thể giúp cho hướng chẩn đoán. Khẳng định bằng các xét nghiệm thấy bilirubin máu tăng cao nhưng chủ yếu thể gián tiếp và siêu âm hay các biện pháp chẩn đoán hình ảnh thấy đường mật không giãn, không có sỏi ...

Ngoài ra, các phản ứng huyết thanh rất có giá trị để chẩn đoán các loại bệnh trên.

2.2. Bệnh ngoại khoa

- U vùng bóng Vater:

+ Vàng da liên tục, tăng dần kèm phân bạc màu và ngứa.

+ Đau bụng thường xuất hiện muộn: Giai đoạn cuối của bệnh.

+ Toàn thân biểu hiện mệt mỏi, gầy sút không rõ nguyên nhân. Sốt cũng thường xuất hiện ở giai đoạn cuối.

+ Xét nghiệm: Bilirubin máu thường tăng rất cao. Xét nghiệm chất chỉ thị u như CEA, CA 19-9 tăng.

+ Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, siêu âm nội soi, siêu âm nội soi trong lòng ống hay chụp cắt lớp vi tính đa dãy giúp xác định chẩn đoán và đánh giá được khả năng cắt bỏ khối u.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- *U nang ống mật chủ:* Thường gặp ở trẻ em, đau bụng vùng gan không thường xuyên. Vàng da không điển hình. Có thể thấy khối ở hạ sườn phải.

Siêu âm, chụp cộng hưởng từ đường mật có giá trị xác định chẩn đoán.

- *Ung thư đường mật* (cholangiocarcinoma):

+ Thường gặp vàng da tăng dần, đau ít và sốt ít trong giai đoạn đầu, da vàng sẫm.

+ Khám thấy gan to, mật độ chắc. Túi mật có thể to nếu u gây tắc ở dưới chỗ đổ vào của ống cổ túi mật.

+ Xét nghiệm: Biểu hiện tình trạng tắc mật như bilirubine máu và phosphatase kiềm tăng. Chất chỉ thị u như CEA và CA_{19-9} tăng trong nhiều trường hợp.

+ Chẩn đoán hình ảnh:

- Siêu âm: Gan to, hay gặp hình thái tổn thương giảm âm và đồng âm trong đường mật, ít gặp khối hỗn hợp âm, hình ảnh thành đường mật dày lên và chít hẹp, đường mật phía trên giãn. Cấu trúc âm giống nhu mô gan nên dễ bỏ sót.
- Chụp ERCP ít áp dụng do nguy cơ nhiễm khuẩn ngược dòng.
- Chụp cộng hưởng từ hay chụp CT Scanner đa dãy cho những thông tin có giá trị trong chẩn đoán xác định, chẩn đoán giai đoạn của u và chẩn đoán khả năng phẫu thuật.

- *Hẹp đường mật sau chấn thương hay phẫu thuật* (tiền sử phẫu thuật cắt dạ dày, mở ống mật chủ cũ, sau cắt túi mật ...). Biểu hiện:

+ Đau vùng gan ít, tăng dần, vàng da tăng dần, sốt giai đoạn cuối. Có thể phân bạc màu. Khám thấy gan to, túi mật to.

+ Xét nghiệm: Tăng bilirubin trực tiếp.

+ Siêu âm gan mật: Đường mật trên chỗ tắc giãn.

+ Chụp đường mật qua da, chụp cộng hưởng từ đường mật: Đường mật trên thương tổn giãn. Đường mật tại chỗ tổn thương chít hẹp.

III. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

Viêm đường mật cấp tính nếu không được điều trị sẽ gây ra các biến chứng cấp tính khác đe dọa tính mạng người bệnh. Chẩn đoán và điều trị các biến chứng cấp tính có vai trò quan trọng trong điều trị sỏi mật.

1. Thấm mật phúc mạc

Do tắc mật làm áp lực trong lòng đường mật cao, gây thấm dịch mật vào trong ổ bụng. Không có tổn thương đại thể đường mật và gan, không có vi khuẩn trong ổ bụng. Là biến chứng thường gặp, phải mổ cấp cứu.

- Lâm sàng: Bệnh cảnh tắc mật cấp do sỏi, nhưng đau nhiều hơn và lan rộng xuống mạng sườn phải, hố chậu phải rồi lan khắp bụng. Thăm khám thấy bụng trướng, tăng cảm giác đau và có phản ứng thành bụng khắp bụng hay có dấu hiệu cảm ứng phúc mạc, ít khi thấy co cứng thành bụng. Thăm trực tràng thấy túi cùng Douglas phồng đau.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính cho thấy có dịch ổ bụng + Hình ảnh tắc mật do sỏi.

- Điều trị: Phải mổ cấp cứu càng sớm càng tốt.

2. Viêm phúc mạc mật

- Do tắc mật gây hoại tử đường mật, túi mật hay áp xe gan vỡ, qua đó, dịch mật cùng vi khuẩn tràn vào trong ổ bụng. Là một biến chứng nặng.

- Bệnh cảnh lâm sàng biểu hiện tương tự thấm mật phúc mạc, tình trạng toàn thân thường có hội chứng nhiễm khuẩn rầm rộ hơn và suy sụp nhanh chóng.

- Điều trị: Phải mổ cấp cứu càng sớm càng tốt.

3. Sốc nhiễm trùng đường mật

Là biến chứng nặng và là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong trong sỏi đường mật. Phải phối hợp điều trị tích cực cả hồi sức và ngoại khoa.

- Biểu hiện: Hội chứng đáp ứng toàn thể (có ít nhất ≥ 2 triệu chứng: Thân nhiệt trên 38°C hay dưới 36°C. Tần số tim > 90 chu kỳ/phút. Tần số thở > 20 lần/phút hay $PaCO_2$ < 32 mmHg. Số lượng bạch cầu máu hoặc > 12 G/l hoặc < 4 G/l do nhiễm khuẩn) và có suy chức năng của cơ quan, giảm tưới máu tổ chức, biểu hiện bằng tăng acid lactic máu, thiểu niệu, thay đổi tri giác, thiếu oxy máu hay tụt huyết áp (huyết áp tâm thu < 90 mmHg hay giảm ít nhất 40 mmHg so với số đo thường ngày ở người tăng huyết áp mà không do nguyên nhân khác như sốc tim, sốc mất máu …).

- Điều trị: Phải dẫn lưu giảm áp đường mật cấp cứu phối hợp điều trị suy tạng, chống nhiễm khuẩn đường mật và xử trí nguyên nhân khi tình trạng bệnh nhân cho phép.

4. Áp xe gan đường mật và các biến chứng

- Là một biến chứng nặng, tình trạng toàn thân suy sụp, sốt cao liên tục kéo dài, đau không giảm, tăng lên khi hít sâu, khi sờ nắn trên gan. Rung gan ấn kẽ sườn (+).

- Chẩn đoán hình ảnh: Cho thấy hình ảnh ổ áp xe đường mật với đặc điểm thường gặp là nhiều ổ ở nhiều vị trí với kích thước khác nhau thông với đường mật (cộng hưởng từ đường mật hay chụp đường mật có cản quang cho thấy hình ảnh "chùm hoa và cành hoa"), cho biết tình trạng đường mật và sỏi đường mật.

- Điều trị: Cần dẫn lưu giảm áp đường mật cấp cứu và mổ sớm.

5. Chảy máu đường mật

- Là một biến chứng nặng, gây khó khăn trong điều trị, tỉ lệ tử vong cao.

- Lâm sàng:

+ Biểu hiện kinh điển của chảy máu đường mật được Quincke mô tả năm 1871 với các triệu chứng đau dưới sườn phải, chảy máu đường tiêu hóa trên và vàng da nhưng chỉ chiếm 22-35% các trường hợp. Nguyên nhân do chấn thương, do can thiệp y

zalo nhóm duy nhất 0528112107

khoa, do bệnh lý gan mật ác tính hay dị dạng mạch vỡ vào đường mật ... là những nguyên nhân thường gặp của chảy máu đường mật ở Âu Mỹ. Máu cục gây tắc đường mật làm biểu hiện đau và vàng da. Dấu hiệu Foldari (nôn ra cục máu đông hình thỏi bút chì) hiếm gặp nhưng rất có giá trị chẩn đoán trên lâm sàng.

+ Chảy máu đường mật do biến chứng của sỏi đường mật chính ở Việt Nam lại có đặc điểm khác với chảy máu đường mật gặp ở châu Âu được Tôn Thất Tùng mô tả là "Chảy máu đường mật nhiệt đới" với đặc điểm chảy máu đường tiêu hóa trên dai dẳng, kéo dài không có quy luật kèm với triệu chứng của sỏi mật (đau vùng gan kèm sốt, vàng da vàng mắt).

- Nội soi tiêu hóa: Có thể thấy dịch mật lẫn máu chảy xuống tá tràng qua nhú Vater.

- Siêu âm: Thấy hình ảnh sỏi mật kèm hình ảnh của cục máu đông trong đường mật.

- CT Scanner: Là lựa chọn đầu tiên do không xâm lấn như chụp mạch, có thể thấy thoát thuốc sang đường mật hay hình giả phình mạch.

- Điều trị:

+ Mổ cấp cứu khi chảy máu ồ ạt (ít gặp) hay mổ cấp cứu có trì hoãn. Quan trọng là tìm vị trí chảy máu để xử trí cắt gan hạ phân thùy hay phân thùy mới xử lý triệt để nguồn gốc chảy máu.

+ Nút động mạch gan chọn lọc là kỹ thuật được lựa chọn khi có hình ảnh chảy máu trên CT Scanner.

+ Mổ thắt động mạch gan kèm lấy sỏi dẫn lưu Kehr đường mật ngày nay ít làm do nguy cơ chảy máu tái phát cao.

6. Viêm tụy cấp

- Là một biến chứng nặng cần can thiệp cấp cứu, tổn thương tụy có thể là hình thái thể phù hay hoại tử.

- Bệnh cảnh lâm sàng tắc mật cấp, đau dữ dội hơn, lan rộng ở vùng trên rốn, xuyên ra sau lưng, sau lan khắp bụng. Thăm khám: Ngoài các triệu chứng của tắc mật cấp còn gặp phản ứng vùng trên rốn, điểm sườn lưng đau. Xét nghiệm amylase trong máu tăng gấp 3 lần giá trị tối đa bình thường. Siêu âm hay chụp cắt lớp thấy có tình trạng tắc mật do sỏi phần thấp ống mật chủ và hình ảnh tổn thương của tụy bị viêm cấp tính.

- Điều trị: Phối hợp điều trị viêm tụy cấp và giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn (can thiệp hay phẫu thuật) đồng thời với điều trị nhiễm khuẩn đường mật.

7. Suy thận

- Là một biến chứng khá thường gặp, do độc tố của vi khuẩn theo dòng máu tới phá hủy cấu trúc của thận.

- Bệnh cảnh lâm sàng tắc mật cấp kèm các dấu hiệu suy thận như thiểu niệu hay vô niệu, ure, creatinin máu. Khi suy thận nặng có thể gặp rối loạn đông máu kèm theo trong bệnh cảnh suy đa phủ tạng mà trước đây được dùng danh từ "thể vàng da chảy máu, ure máu cao" để chỉ hình thái nặng có tỉ lệ tử vong cao này.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Điều trị phối hợp dẫn lưu giảm áp đường mật cấp cứu, hồi sức cấp cứu và xử lý nguyên nhân khi tình trạng bệnh nhân cho phép.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc điều trị

1.1. Điều trị nội khoa: Là biện pháp áp dụng trước tiên.

- Giảm đau: Sử dụng thuốc giãn cơ trơn vv....

- Chống nhiễm khuẩn đường mật: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, nhạy cảm với vi khuẩn Gram (-) thải trừ chủ yếu qua đường mật phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn kỵ khí ở hình thái nhiễm khuẩn nặng.

- Điều chỉnh các rối loạn nếu có.

- Ngoài đợt tắc mật: Sử dụng thuốc lợi mật nhằm làm tăng lưu lượng dịch mật chống nhiễm khuẩn đường mật và làm trôi những viên sỏi nhỏ có đường kính ≤ 3 mm xuống ruột.

- Tẩy giun trước mổ phiên nhằm tránh giun lên đường mật sau mổ. Đối với những trường hợp mổ cấp cứu, cần tẩy giun ngay sau khi có nhu động ruột trở lại.

1.2. Điều trị ngoại khoa

Nhằm mục đích lấy hết sỏi, giun ... trong đường mật, đảm bảo lưu thông dịch mật với đường tiêu hóa.

2. Các phương pháp điều trị

2.1. Ngoại khoa

- Mở ống mật chủ lấy sỏi có hoặc không dẫn lưu Kehr:

Mổ mở: Là phương pháp kinh điển thường được áp dụng. Ưu điểm của phương pháp là tôn trọng giải phẫu đường mật, thời gian mổ không quá kéo dài, kỹ thuật không quá phức tạp, áp dụng được ở các cơ sở ngoại khoa.

Mổ nội soi ổ bụng: Ở các cơ sở ngoại khoa có trang thiết bị mổ nội soi, phẫu thuật viên có kỹ năng tốt, tình trạng người bệnh cho phép có thể mổ nội soi lấy sỏi đường mật tối đa và tán sỏi qua đường hầm Kehr sau mổ cho kết quả sạch sỏi cao từ 80-95%..

+ Chỉ định: Cho các trường hợp sỏi đường mật chính không có chỉ định lấy sỏi qua nội soi ngược dòng hay qua da.

+ Chống chỉ định: Khi có rối loạn đông máu nặng, bệnh lý phối hợp nặng không gây mê được (ASA 5, 6).

+ Các bước kỹ thuật chính:

- Gây mê nội khí quản.
- Đường mổ: Thường đi đường trắng giữa trên rốn. Có thể đi đường dưới bờ sườn phải.
- Thăm dò đánh giá tình trạng gan, đường mật và các tạng trong ổ bụng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Mở ống mật chủ lấy sỏi. Tùy theo vị trí sỏi, kích thước ống mật chủ, phương tiện và kỹ năng mà mở dọc hay ngang ống mật chủ, dài hay ngắn khác nhau. Nếu ống cổ túi mật to, sỏi chỉ ở phần thấp ống mật chủ, có thể lấy sỏi qua ống cổ túi mật sau khi cắt túi mật. Lấy sỏi bằng dụng cụ gắp sỏi như Mirizzi hay bằng rọ Dormia, bằng máy nội soi tán sỏi điện thủy lực hay laser Holmium ...
- Kiểm tra lưu thông đường mật - tá tràng. Đặt dẫn lưu Kehr (dẫn lưu chữ T) đường mật, cỡ ống tùy theo kích thước đường mật và mục đích đặt, khâu chỗ mở ống mật chủ bằng chỉ tiêu. Có thể khâu kín không đặt dẫn lưu đường mật khi đạt các tiêu chuẩn: Hết sỏi, không viêm mủ đường mật, đường mật lưu thông tốt, khả năng liền sẹo sinh lý của bệnh nhân bình thường.
- Đặt 1 dẫn lưu dưới gan, cạnh chỗ mở ống mật chủ.
- Đóng thành bụng.

+ Tai biến, biến chứng:

- Tai biến: Tổn thương tá tràng, đại tràng nhất là ở bệnh nhân mổ lại. Xử trí khâu vết rách thường mang lại kết quả tốt. Tổn thương phức tạp cần phẫu thuật viên có kinh nghiệm. Các tai biến khác hiếm gặp như vết thương động mạch gan riêng, tĩnh mạch cửa cần được xử trí chuyên khoa mạch máu.
- Biến chứng: Hay gặp là *nhiễm khuẩn vết mổ*, thường khỏi bằng điều trị chăm sóc tại chỗ. *Viêm phúc mạc sau mổ*, phải mổ lại càng sớm càng tốt. *Rò mật*: Bắt đầu bằng điều trị bảo tồn không mổ, bù nước điện giải, chống nhiễm khuẩn và viêm loét tại chỗ, dùng thuốc giảm bài tiết dịch mật, nếu có tắc nghẽn bên dưới thì phải giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn. *Áp xe tồn dư*: Điều trị bằng dẫn lưu dưới siêu âm và kháng sinh đường toàn thân thường đạt kết quả tốt. *Chảy máu sau mổ trong ổ bụng*: Nếu chảy nhiều phải mổ tìm nguyên nhân cầm máu. *Chảy máu đường mật*: Bơm rửa đường mật bằng NaCl 0,9% ấm và kháng sinh thường có hiệu quả khi chảy mức độ nhẹ. Nếu chảy nhiều phải chụp mạch và nút mạch hay phải mổ lại để cầm máu.

- Phẫu thuật phối hợp:

+ Nối ống mật chủ - đường tiêu hóa: Được thực hiện sau khi lấy sỏi nhằm tạo đường lưu thông nhân tạo từ đường mật xuống đường tiêu hóa, áp dụng khi chít hẹp ở phần thấp ống mật chủ hay còn sỏi trong gan ở bệnh nhân đã mổ nhiều lần, tuổi cao nhằm tránh nguy cơ phải mổ lại do sỏi tiếp tục gây tắc đường mật và gây biến chứng. thường nối ống mật chủ với hỗng tràng trên quai chữ Y (Roux- en - Y), ít khi nối với tá tràng vì nguy cơ nhiễm khuẩn đường mật ngược dòng cao.

+ Cắt túi mật: Khi có tổn thương túi mật phối hợp (viêm, sỏi, polyp ...) hay khi nối đường mật với ống tiêu hóa.

+ Mở nhu mô gan lấy sỏi: Mở nhu mô gan lấy sỏi phối hợp đặt dẫn lưu đường mật trong gan qua nhu mô được F.Glenn và F.G Moody thực hiện lần đầu năm 1961, áp dụng cho trường hợp sỏi trong gan có chít hẹp đường mật. Vị trí mở nhu mô ở các hạ phân thùy II, III bên gan trái và V, VI bên gan phải, tương ứng với vị trí ống mật sát vỏ Glisson (dưới 1 cm) nhằm tránh nguy cơ gây tổn thương nhu mô gan và các mạch máu trong nhu mô. Ưu điểm là tiếp cận thuận lợi với sỏi trong gan ở vị trí sát nhu mô, nếu đi

zalo nhóm duy nhất 0528112107

từ chỗ mở ống mật chủ sẽ không tới được do quá xa hoặc do đường mật bị hẹp, bị gập góc nhọn không thể vào được để lấy sỏi hay khó lấy sỏi. Qua chỗ mở nhu mô lấy sỏi và nong đường mật bị hẹp phía dưới, đặt dẫn lưu trong gan qua nhu mô nhằm dẫn lưu dịch mật nhiễm trùng, làm giảm áp lực đường mật, tránh hẹp lại sau nong đường mật và đảm bảo lưu thông dịch mật tốt. Tỷ lệ mở nhu mô gan lấy sỏi trên chỗ hẹp đường mật trong gan 4,3%. Theo dõi sau 8 tháng - 7 năm, tỉ lệ hẹp lại là 40%, tái phát sỏi sau nong là 75%. Chống chỉ định khi sỏi ở sâu trong nhu mô, phần gan có sỏi teo mất chức năng hay nghi ngờ ung thư.

+ Nong đoạn đường mật bị chít hẹp hay mở rộng bằng laser bốc hơi Thulium.

- Cắt gan:

+ Chỉ định cắt gan trong sỏi đường mật: Khi phần gan chứa sỏi khu trú teo nhỏ (thường có chít hẹp đường mật kèm theo), nhiều ổ áp xe gan khu trú ở mức độ phân thùy hay hạ phân thùy, khi bị hay nghi ngờ ung thư đường mật hoặc phần gan cắt là vị trí chảy máu đường mật mà không xử trí được bằng các phương pháp khác.

+ Chống chỉ định: Bệnh nhân có rối loạn đông máu, xơ gan nặng, bệnh lý toàn thân phối hợp nặng (ASA 5, 6).

+ Các bước kỹ thuật chính: Thường áp dụng cắt gan nhỏ trong bệnh lý sỏi mật, phương pháp cắt gan Tôn Thất Tùng mang lại hiệu quả cao trong điều trị nhất là khi không có chụp đường mật trong mổ, tránh được nguy cơ do biến đổi giải phẫu đường mật trong gan. Cần chú ý đảm bảo lưu thông đường mật dưới chỗ cắt để tránh rò mật.

+ Tai biến, biến chứng tương tự như trong mổ sỏi đường mật chính và cắt gan do u, nguy cơ nhiễm khuẩn và rò mật cao hơn do cắt gan trong bệnh lý sỏi mật ở trên cơ địa nhiễm khuẩn đường mật. Tỷ lệ biến chứng và tử vong tương ứng 22-33% và 1-2,3%.

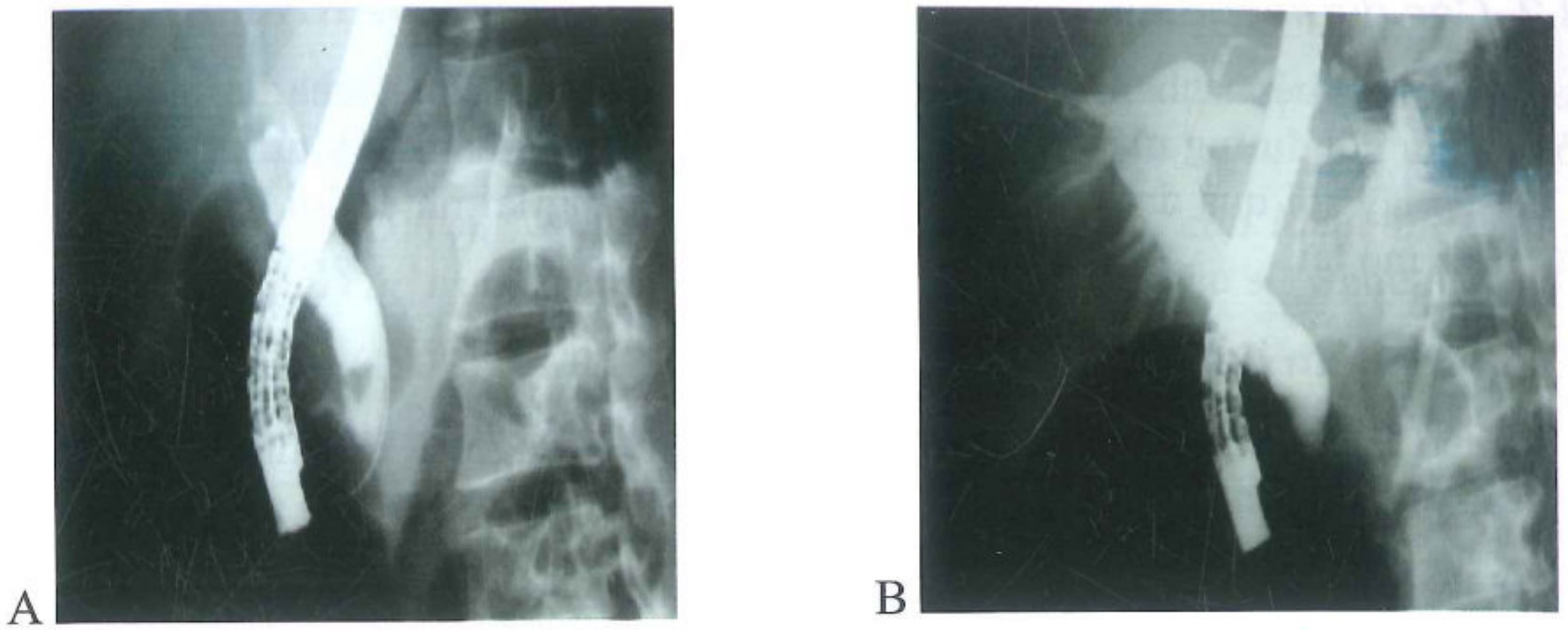
+ Kết quả: Tỷ lệ sạch sỏi cao hơn, tỷ lệ tái phát thấp hơn khi không cắt gan.

2.2. Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

Dẫn lưu đường mật phối hợp điều trị kháng sinh chống nhiễm khuẩn đường mật đã giúp hạ tỷ lệ chết từ > 50% trong những năm 70 xuống dưới 7% trong những năm 80 của thế kỷ trước. Dẫn lưu đường mật bằng phương pháp ít xâm hại như ERCP là lựa chọn hàng đầu vì ít xâm lấn và ít nguy cơ hơn các phương pháp khác, qua đó đặt dẫn lưu mũi mật hoặc stent đường mật. Khi không làm được qua đường nội soi ngược dòng (bệnh nhân có túi thừa lớn D2 hay đã cắt dạ dày Billroth 2 ...), thủ thuật dẫn lưu đường mật theo đường xuyên gan qua da được lựa chọn. Mổ lấy sỏi, dẫn lưu đường mật là lựa chọn sau hai lựa chọn trên.

- Chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi: Trước đây được áp dụng cho bệnh nhân bị sỏi phần thấp ống mật chủ có nhiều nguy cơ khi phẫu thuật và gây mê như bệnh nhân mổ lại, tuổi cao vv.... Ngày nay, áp dụng dẫn lưu giảm áp đường mật cấp cứu hay dẫn lưu sớm cho nhiễm khuẩn đường mật cấp tính độ 2, 3 (phân loại Tokyo) và lấy sỏi thì 2 khi có chỉ định và tình trạng bệnh nhân cho phép. Với sỏi kích thước < 1 cm hầu như không phải cắt cơ thắt để lấy sỏi, với sỏi lớn hơn khả năng lấy sỏi phụ thuộc vào trang thiết bị (rọ cắt sỏi, máy tán sỏi ...) và kỹ năng của thầy thuốc làm thủ thuật. Phương pháp lấy sỏi qua nội soi ngược dòng rất hạn chế khi có sỏi trong gan (kể cả trường hợp có máy soi mẹ - con) và khi sỏi to đúc khuôn ống mật chủ.

zalo nhóm duy nhất 0528112107



A B

Hình 4. (A). ERCP trước khi lấy sỏi (B). Sau khi lấy sỏi

- Chống chỉ định: Bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, đang dùng thuốc chống đông máu, không gây mê được, thay đổi giải phẫu sau mổ không đưa ống soi vào được ...

- Tai biến, biến chứng chiếm khoảng 6,8% theo thứ tự hay gặp là viêm tụy cấp, viêm đường mật và viêm túi mật, chảy máu tiêu hóa cao, thủng tá tràng, thủng đường mật liên quan với cắt cơ thắt Oddi và là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong. Tai biến khác chiếm 1,3% như tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da, kẹt rọ trong ống mật chủ vv.... Tỷ lệ tử vong ≤ 1%.

2.3. Tán sỏi đường mật qua da

2.3.1. Tán sỏi đường mật theo đường xuyên gan qua da

Chụp đường mật qua da được Huart và Đỗ Xuân Hợp thực hiện lần đầu tiên trên thế giới năm 1937 tại Bệnh viện Phủ Doãn. Trong vài thập kỷ gần đây, kỹ thuật này được phát triển mạnh mẽ không những áp dụng trong chẩn đoán nhờ ưu điểm đưa thuốc cản quang trực tiếp vào đường mật nên thấy rõ nét cây mật, vị trí tắc, bản chất vật tắc, các biến đổi giải phẫu, mà còn được áp dụng trong điều trị sỏi mật trong và ngoài gan, trong điều trị chít hẹp đường mật và chít hẹp miệng nối mật - ruột.

Trong điều trị viêm đường mật cấp tính, dẫn lưu giảm áp đường mật qua da là phương pháp được lựa chọn khi không can thiệp lấy sỏi ngược dòng được. Khi có chỉ định và tình trạng bệnh nhân cho phép sẽ tiến hành tán sỏi đường mật theo đường xuyên gan qua da. Tỷ lệ thành công 86% khi đường mật giãn và 63% khi đường mật không giãn.

- Chỉ định: Sỏi đường mật đã có dẫn lưu đường mật qua da, sỏi trong gan ở bệnh nhân đã mổ nhiều lần có nguy cơ phẫu thuật cao hay không đồng ý mổ lại.

- Chống chỉ định: Bệnh nhân bị rối loạn đông máu. Bệnh nhân phải mổ để xử lý tổn thương (cắt gan, cắt túi mật vv …).

- Tai biến, biến chứng (7,8-39%): Có thể gặp chảy máu đường mật, chảy máu trong ổ bụng, nhiễm khuẩn máu, rò mật, tràn mật ổ bụng, tụt ống dẫn lưu vv... Tỷ lệ chết ≤ 1%.

- Kết quả: Tán sỏi đường mật theo đường xuyên gan qua da có tỷ lệ hết sỏi cao - 83,5%.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2.3.2. Các đường qua da khác

Ở những bệnh nhân đã được tạo đường vào đường mật qua da như để đầu ruột dưới da sau nối đường mật với hỗng tràng, đã có đường hầm da - túi mật - ống mật chủ …, tán và lấy sỏi qua da theo đường đã tạo sẵn mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tránh phải mổ lại.

3. Điều trị viêm đường mật cấp tính

Theo Hướng dẫn Tokyo 2018, điều trị viêm đường mật cấp tính tùy theo mức độ nặng của viêm đường mật, cụ thể như sau:

- Độ 1: Điều trị nội khoa, dẫn lưu đường mật nếu không đáp ứng, điều trị nguyên nhân (nội soi ngược dòng, qua da, phẫu thuật).

- Độ 2: Điều trị nội khoa và dẫn lưu đường mật sớm, điều trị nguyên nhân (nội soi ngược dòng, qua da, phẫu thuật).

- Độ 3: Dẫn lưu đường mật cấp cứu phối hợp chống rối loạn chức năng các cơ quan và chống viêm đường mật cấp tính. Khi ổn định, điều trị nguyên nhân (nội soi ngược dòng, qua da, phẫu thuật).

4. Săn sóc sau mổ và điều trị sỏi sót

- Săn sóc dẫn lưu Kehr: Đảm bảo nguyên tắc kín, vô trùng, một chiều. Khi lưu Kehr điều trị sỏi sót, phải cung cấp kiến thức cho bệnh nhân để đảm bảo vô trùng, không để Kehr quá lâu gây nguy cơ thủng vào ống tiêu hóa. Chỉ rút Kehr khi thoả mãn điều kiện rút, lưu ý cố định Kehr tốt tránh bị tụt do để lâu ngày.

- Điều trị sỏi sót sau mổ bằng bơm rửa NaCl $9^0/_{00}$, 500-1000 ml hàng ngày qua Kehr. Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn nhằm đẩy sỏi nhỏ xuống ruột, sỏi trong gan rơi xuống thấp nhằm lấy dễ dàng hơn bằng nội soi tán sỏi theo đường hầm của Kehr là phương pháp thường áp dụng nhất hiện nay.

- Nội soi lấy sỏi qua đường hầm Kehr có thể áp dụng ít nhất sau mổ $\geq$ 3 tuần khi đường hầm Kehr đã xơ hóa đủ chắc. Phương pháp Pribram ngày nay ít làm.

V. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ vai trò của phòng bệnh, tẩy giun định kỳ, dùng thuốc lợi mật nguồn gốc thảo mộc (nhân trần, actiso) hàng ngày, tránh nhiễm khuẩn đường mật.

- Cung cấp các thông tin về các triệu chứng sớm của bệnh để bệnh nhân biết tầm quan trọng của đi khám định kỳ kiểm tra sau mổ nhằm xử trí sớm khi sỏi tái phát.

- Trường hợp lưu Kehr cần giải thích rõ cho bệnh nhân biết mục đích lưu Kehr, cách chăm sóc tránh nhiễm khuẩn ngược dòng, khi có dấu hiệu bất thường phải đến khám lại ngay, và phải đến khám đúng hẹn tránh để ống quá lâu gây hoại tử các tạng lân cận gây nguy hiểm đến tính mạng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đình Hối (2000), "*Bệnh sỏi đường mật ở Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra*", Ngoại khoa, XL(2), tr 1- 13.
2. Trần Bảo Long (2004), *Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và kết quả các trường hợp sỏi mật mổ lại*, Luận án Tiến sĩ y học, Hà Nội.
3. Tôn Thất Tùng (1971), "*Chảy máu đường mật vùng nhiệt đới*", Cắt gan, Nhà xuất bản KHKT, tr 243-258.
4. Tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị sỏi mật (2020), NXB Y học, Hà Nội.
5. Rani Berrya, James Y. Hanb, Ani A. Kardashianet al (2018), "*Hemobilia: Etiology, diagnosis, and treatment*", Liver Research, December ; 2(4): 200-208
6. Seiki Kiriyama Kazuto Kozaka Tadahiro Takada et al (2018), *Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading ofacute cholangitis (with videos)*, J Hepatobiliary Pancreat Sci 25:17–30.
7. Fumihiko Miura Kohji Okamoto Tadahiro Takada et al (2018), *Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infectionand flowchart for acute cholangitis*, J Hepatobiliary Pancreat Sci 25:31-40.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày những đặc điểm giải phẫu đường mật có liên quan được ứng dụng trong bệnh sỏi đường mật và cơ chế tạo sỏi mật?

Câu 2. Hãy trình bày chẩn đoán xác định sỏi đường mật và các biến chứng cấp tính?

Câu 3. Hãy trình bày nguyên tắc và các phương pháp điều trị sỏi đường mật và các biến chứng cấp tính?

Câu 4. Theo anh (chị) cần làm gì để phòng sỏi đường mật tái phát?

zalo nhóm duy nhất 0528112107